Processo nº 0077984-57.2022.8.17.2001

AUTOR: FABIO DOS SANTOS

RÉU: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por **FABIO DOS SANTOS**, através de advogado (ID 110022089), em face da **UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, objetivando, em sede de tutela de urgência, compelir as rés a fornecerem o tratamento medicamentoso SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranal), até a duração do tratamento e na quantidade solicitada pela médica assistente (laudos médicos de ID 110022095 a 110022100).

O autor, com 53 anos de idade, informa ser beneficiário de plano de saúde individual/familiar das rés há quase 14 (catorze) anos (IDs 110022086 e 110022092), adimplente com as mensalidades (ID 110022093), com diagnostico de transtorno depressivo grave há 30 (trinta) anos, já se submeteu a diversos tratamentos, fez uso de todas as medicações antidepressivas disponíveis no mercado.

Em decorrência de agravamento de seu quadro de saúde, não responde mais aos medicamentos que estavam sendo utilizados, chegando a um diagnóstico atual de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave (CID 10 F33.2), razão pela qual a psiquiatra assistente, Kátia Cristina Lima Petribu (CRM nº 9282-PE), prescreveu, em caráter de emergência, a medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intrenal), para uso imediato, devendo ser ministrada em ambiente hospitalar (ID 110022095), ante o risco imimente de suicídio.

Todavia, assevera que ao solicitar autorização para dar início imediato ao tratamento, através do Autorizador Web – Unimed Recife, Protocolo (2311532), adveio a negativa da Unimed local, sob o fundamento de que a medicação SPRAVATO não tem

cobertura pela RN 465/2021, por isso a Unimed Recife não fornece, ficando a critério da Unimed Natal verificar o contrato do usuário e tratar diretamente do processo (ID 110022101).

O autor esclarece que sempre requereu autorização para os procedimentos junto à Unimed Recife, onde sempre é atendido em casos de urgência e emergência, nos termos da cláusula 4.1 do contrato (ID 110022092 - Pág. 18).

Dado ao narrado, propõe a presente demanda. No mérito, pretende a confirmação da tutela e condenação da ré em indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00. Atribui à causa o valor de R$ 88.000,00, sendo R$ 68.000,00 referente ao tratamento (orçamento de ID 110022102) e R$ 20.000,00 correspondente a danos morais. Requer os benefícios da justiça gratuita.

Despacho inaugural defere o benefício da justiça gratuita e determina a intimação/citação das rés para falarem sobre o pedido de tutela de urgência, bem como para comparecer à audiência do art. 334, designada para o dia 07/10/2022, às 12h00 (ID 111348399).

Expede-se carta de citação/intimação (ID 111577177) e certifica-se a realização da intimação pessoal da Unimed Recife em 05/08/2022 (ID 111738653).

A **Unimed Recife** manifesta-se acerca do pedido de tutela no ID 112035404. Centra a sua defesa na alegação de sua ilegitimidade passiva para a demanda, por ser o contrato do autor firmado junto à Unimed Natal, empresa independente da Unimed Recife.

A **Unimed Natal**, por sua vez, apresenta oposição ao pleito liminar no ID 112100155. Em síntese, alega que o fármaco é de uso ambulatorial, não havendo, no contrato e na RN 387/2015 da ANS, a obrigação de custear medicamentos ambulatoriais e de uso domiciliar. Aponta ainda que, considerando o valor unitário da medicação (R$ 2.019,21), o tratamento por 12 (doze) ciclos ultrapassará a quantia de R$ 200.000,00.

Em sequência, a Unimed Recife oferta contestação sob ID 112141832, repetindo os fundamentos postos na manifestação sobre a tutela (ID 112035404). Ademais, requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais, ao argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito em desfavor da parte autora.

Decisão interlocutória de ID 115477492 defere a tutela antecipada requerida para determinar que as rés autorizem e forneçam o tratamento medicamentoso SPRAVATO, nos moldes solicitados pela psiquiatra assistente.

A **Unimed Natal** oferta contestação no ID 115981992 suscitando, de início, duas preliminares: (i) impugnação a gratuidade judiciária deferida ao autor sob a assertiva de que se encontra assistido por advogado particular e que não pode ser considerada pobre pessoa que trabalha e recebe renda; (ii) impugnação ao valor da causa, já que não pode ser estimado por dedução do beneficiário, sem demonstrar supedâneo para acolhimento.

No mérito, invoca, em síntese, o seguinte: (i) o autor não tem direito a medicação vindicada por ausência de cobertura contratual e legal, pois a cláusula 5.1 do contrato prevê exclusão para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceção feita para medicamentos antineoplásicos orais e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 12, I, c, e II , alínea g, da Lei 9.656/98); (ii) a cláusula contratual restritiva de cobertura se encontra em consonância com o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, estando em atendimento ao disposto no art. 54, § 4º do CDC; (iii) o tratamento indicado se encontra fora do rol da ANS, já que nos termos da Resolução 465/2021 da ANS, para ter cobertura o medicamento tem que estar regularizado pela ANVISA e ser utilizado em tratamento abordado pela referida resolução, nos termos do art. 19, além do que na DUT 109, que trata do atendimento/acompanhamento em hospital dia não é localizado o medicamento indicado; (iv) o Spravato se trata de medicamento *off label*, já que não possui as indicações descritas na bula registrada na ANVISA para o tratamento vindicado pela parte autora, havendo cláusula de exclusão de cobertura para tal situação – item 5.1. 1; (vi) a eficácia, a longo prazo, na prevenção do suicídio não foi estabelecida; (vii)) a limitação de cobertura do plano de saúde é possível desde que atendidos os pressupostos legais e haja previsão clara, precisa e destacada no contrato, o que se verifica no caso em liça em relação às exclusões de cobertura; (viii) deve se atentar para a taxatividade do rol da ANS, de forma que a operadora não pode ser obrigada a custear procedimento que não esteja lá previsto; (ix) ausência de comprovação dos danos morais aduzidos na inicial, já que a ré agiu no exercício regular do direito, em atendimento às cláusulas contratuais, não tendo cometido qualquer ilícito; (ix) o eventual descumprimento contratual sem repercussão na esfera intima do segurado não é passível de configurar dano moral.

Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos atriais, com a condenação da parte autora nos consectários sucumbenciais.

A UNIMED Natal informa o cumprimento da tutela no ID 116190412 e, em sucessivo, noticia a interposição de **Agravo de Instrumento nº 0019287-95.2022.8.17.9000** (ID 117272285).

Decisão de ID 117845886 não exerce juízo de retratação no que toca ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão concessiva da tutela e determina intimação da parte autora para réplica e de ambas as partes para informarem provas a produzir.

A UNIMED Recife informa não ter mais provas a produzir (ID 121196754).

A parte autora, por seu turno, oferta réplica no ID 124767097, pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento, para para inquirição da médica assistente do autor, para esclarecimento sobre o tratamento (continuação do tratamento com a medicação Spravato e o intervalo de tempo para continuidade da aplicação) e, acaso entenda o juízo, pela realização de perícia médica.

A UNIMED Natal se manifesta no ID 124842439 dispensando audiência de instrução e requer a juntada de prova documental – Relatório Unimed Natal – Fármaco Spravato, para evidenciar que a conduta da Unimed em fornecer o medicamento foi lícita, assinado pela Dra. Camila de Medeiros Costa (ID 124842445).

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar. Passo a analisar e decidir.

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/2015, por não haver necessidade de dilação probatória.

Registre-se que a parte autora pugna pela realização de audiência de instrução a fim de ser inquirida a médica assistente que acompanha o autor, no intuito de prestar esclarecimento sobre o tratamento, inclusive no que tange a necessidade de continuação com a medicação indicada e o intervalo de tempo, no entanto, observa-se que tal prova se afigura desinfluente para o julgamento da lide, tendo em vista que o laudo de ID 110022095 é bastante esclarecedor, detalhando em minúcias a situação do paciente e a forma de aplicação da medicação, com dosagem inicial e continuidade do tratamento para quatro semanas e, em seguida, já informando a dosagem de manutenção prescrita, com tratamento a ser seguido, no mínimo, por seis meses, a ser aplicado por via intranasal em ambiente hospitalar (indicação das fases 1, 2 e 3).

Neste contexto, diante da prova documental, em especial o laudo de ID 110022095, reputo que não há necessidade de inquirição da médica assistente, comportando o feito ser julgado no estado em que se encontra.

De início, cumpre registrar que a **preliminar de ilegitimidade passiva** suscitada pela Unimed Recife já foi rechaçada, consoante decisão interlocutória de ID 115477492, porquanto ser assente a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça quanto a “reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp n. 1.741.126/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

A segunda preliminar de **impugnação a gratuidade judiciária**, também não se credencia ao sucesso.

De acordo com o art. 98 do CPC/2015, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, o legislador fez questão de estabelecer que a hipossuficiência financeira se presume verdadeira se suscitada por pessoa natural (art. 99, §3º) e o magistrado só está autorizado a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de adotar tal postura, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§ 2º).

Há de se pontuar que é pacifico na jurisprudência pátria que a contratação de advogado particular "*não repele a presunção de veracidade da alegada situação de pobreza tampouco inibe o seu direito de obter o benefício*" (TJ-PE - AI: 4499532 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017).

Afora isso, vale frisar, a declaração de pobreza pode ser elidida por prova contrária. Contudo, inexiste qualquer elemento a infirmar a hipossuficiência anunciada, pois a impugnação ofertada é genérica e não afasta a presunção de necessidade. A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

> DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. GENÉRICA. FALTA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. MONITÓRIA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. **Preliminar suscitada em contrarrazões, impugnação genérica da gratuidade de justiça. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica do réu, não bastando mera alegação**. (...) (TJDF, 6ª Turma Cível, AC 0704557-78.2018.8.07.0004, Rel. Alfeu Machado, j. 15/05/2019, DJE 24/05/2019)

Desta feita, mantém-se o benefício em favor da requerente.

A **Impugnação valor da causa** segue o mesmo destino da rejeição.

No ponto, cabe reter que é possível, em tese, aferir o conteúdo econômico do pedido de obrigação de fazer, que estaria mensurado pela previsão orçamentária de ID 110022102, fornecida pelo Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, que consigna o valor de R$ 68.000,00, ainda que se trata de obrigação de fazer, sem proveito econômico imediato.

Deste modo, somados os valores apontados de forma estimada, no que tange à obrigação de fazer, com o pedido de danos morais na quantia de R$20.000,00, correto se afigura o valor atribuído à causa. Assim, **inacolho a impugnação, mantendo o valor da causa no montante de R$88.000,00**

Impende destacar que os contratos de plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

O cerne da questão ora posta em pretório centra-se em averiguar se as operadores de saúde demandadas possuem a obrigação de fornecer o medicamento Spravato ao autor, nos moldes em que solicitado pela médica psiquiátrica que o acompanha, diante do seu diagnóstico atual – CID – 10 F 33.2 – com risco iminente de suicídio, assim como se a negativa de cobertura é capaz, ou não, no caso concreto, de ocasionar dano moral.

A Unimed Natal aponta como causa de recusa as seguintes teses: (i) há cláusula expressa de cobertura contratual com relação a fornecimento de medicamento de uso domiciliar e que não tenha previsão no rol da ANS; (ii) não há obrigatoriedade de fornecer medicamento *off label*, que não tenha previsão na bula para a doença da qual é portador o autor; (iii) validade das cláusulas de exclusão previstas no contrato.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Corte da Cidadania já consolidou entendimento no sentido de que a **"operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente(...)"** (AgInt no AREsp 1.072.960/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 8/9/2017).

Neste sentido, segue julgado do STJ:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. **O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado.** Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1185690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Os documentos colacionados aos autos pelo demandante, em especial o relatório da psiquiatra KATIA CRISTINA LIMA DE PETRIBU, CRM 9282 (IDs 110022095 a 110022100), aponta a grave enfermidade que acomete o autor há cerca de 30 (trinta)

anos – **Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual (Grave), CID 10 F33.2** – e a necessidade do tratamento medicamentoso SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal).

No relatório, a médica ainda aponta que, devido a ideação suicida, o autor já foi submetido a outras terapêuticas utilizadas no quatro de depressão grave – eletroconvulsoterapia e tratamento com Cetamina subcutânea, Quetiapina 150 a 200mg/dia, Alprazolan 2mg/dia, Risperidona 3mg/dia, Fluvoxamina 200mg/dia, Ramelteona 8mg/noite, Vortioxetina 20mg/dia, Aglomelatina 50mg/dia – as quais não tiveram eficácia.

Por outro lado, restou comprovada a negativa de cobertura perpetrada pelas demandadas, em síntese, ao argumento de que a medicação SPRAVATO não tem cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – Resolução Normativa 465/2021 da ANS, tanto na resposta administrativa da Unimed Recife (ID 112549542), quanto na manifestação da Unimed Natal colacionada aos autos (ID 112100155).

Sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido nos Embargos de Divergência do **EResp 1886929 e EResp 1889704**, fixou a tese quanto à taxatividade do rol da ANS, em regra, nos seguintes termos:

> 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
>
> 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
>
> 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
>
> 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (STJ, 2ª S, EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 8/6/2022, DJe 3/8/2022.).

Como se vê, segundo a orientação daquela Corte Superior para que possa ser autorizada, excepcionalmente, a realização de procedimento não previsto no Rol da ANS, deve restar demonstrado o preenchimento dos requisitos dispostos no item 4 supratranscrito.

No caso em apreço, verifico que, embora as rés sustentem a legitimidade da negativa no Rol da ANS, não demonstram a existência de negativa expressa da Agência reguladora para a inclusão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Noutra banda, observo que, recentemente, em caso análogo (pessoa com 53 anos de idade, com transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, que fez uso de extensa lista medicações orais sem controle dos sintomas), submetido à elaboração de parecer pelo Sistema e-Natjus, do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, foi proferido parecer favorável ao fornecimento da medicação ora vindicada – Nota Técnica (NT) nº 93152, data de conclusão 06/09/2022 (em anexo).

Registre-se que a NT nº 93152 consigna, expressamente, que a conclusão "*favorável*" ou "*desfavorável*", contidas nas notas técnicas do NAT-Jus, "*diz respeito tão somente as evidencias cientificas sobre a metodologia em foco e a indicação do seu custeio pelo poder público ou saúde suplementar, considerando as opções terapêuticas disponíveis*".

Dado ao narrado, tem-se por demonstrado que o presente caso enquadra-se na situação que excepciona a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS prevista no item 4 do EREsp n. 1.886.929/SP.

Ademais, no que tange a assertiva de que o medicamento não possui previsão no rol da ANS para a moléstia que acomete o autor, há de se pontuar, que os Tribunais pátrios firmaram entendimento majoritário no sentido de que o Rol da ANS tinha caráter meramente exemplificativo, constituindo referência das coberturas mínimas obrigatórias, mas não excluindo outras que se façam necessárias, por expressa indicação médica, para o tratamento de doença coberta contratualmente. Ou seja, se a doença é coberta contratualmente, o seu tratamento - de acordo com a indicação médica - também deve ser. Neste sentido, cita-se julgado proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

> "**Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma**. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1981303/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe **19/04/2022**).

Posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade do Rol da ANS, contudo, com algumas ressalvas, especialmente quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, considerando o quadro clínico do

paciente, a evolução da doença mesmo com outros tratamentos, elemento este já preenchido no caso em liça, consoante já tratado nesta decisão.

Assim, para pôr fim às oscilações jurisprudenciais, recentemente foi sancionada a **Lei nº 14.454/2022**, a qual estabelece critérios que determinam a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos do sistema de saúde suplementar, **desde que comprovada a sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**, o que, do relatório médico de ID 110022097, infere-se ser a hipótese dos autos, *in verbis*:

> *"Em sua última consulta realizada no dia 18-5-2022 modifiquei sua prescrição para quetiapina 150 a 200 mg-dia, Alprazolan 2 mg ao dia, risperidona 3 mg ao dia, fluvoxamina 200 mg ao dia, ramelteona 8 mg a noite. Vinha em uso de vortioxetina 20 mg ao dia, agomelatina – 50 mg ao dia, Alprazolan 2 mg ao dia, quetiapina 50 mg- ao deitar, ramelteona 8mg a noite, sem nenhuma eficácia. Contudo, levando em consideração todos esses fatos, como médica assistente do Sr. Fábio dos Santos devo utilizar a terapia mais indicada para este paciente, a fim de promover o resgate do quadro grave em que se encontra, pois é sabido que a suicidalidade é uma emergência psiquiátrica que exige intervenção imediata, e o intervalo de tempo entre o surgimento da ideação suicida e a tentativa de suicídio é geralmente muito curto.*
>
> *Portanto, considerando-se o diagnóstico atual do paciente (CID-10: F 33.2), O RISTO IMINENTE DE SUICÍDIO, considerando ainda que as atuais medicações não respondem, assim como o risco de autoextermínio do paciente, refratariedade das terapias acima citadas, solicito a Unimed o tratamento abaixo:*
>
> *Liberação urgente, em caráter de emergência, da medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranal) a ser indicado imediatamente, na dosagem de 56 mg (4 dispositivos) para a 1ª semana. Dando continuidade ao tratamento conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA, no total de quatro semanas, realizando mais 6 aplicações de 84 mg (3 dispositivos por aplicação, ou seja, 18 dispositivos para as semanas 2, 3e 4), em dias alternados, conforme evolução do quadro em que o paciente se encontra, totalizando 22 (vinte e dois) dispositivos a serem administrados de acordo com prescrição médica – vide receituário branco carbonado em duas vias anexo ao presente relatório (...)*
>
> *As consequências de um tratamento ineficiente levou o paciente a uma redução da qualidade de vida, bem como de sua vida sacerdotal e de todos que dele necessitam. O tratamento proposto tem o objetivo de evitar e/ou reduzir tentativas de suicídio e piora do paciente*
>
> *É uma medicação aprovada pela ANVISA, e deve ser utilizada em conjunto com uma terapia antidepressiva oral, para a rápida redução"*

Portanto, configura-se preenchido o critério estabelecido no parágrafo 13, do artigo 10, da Lei 9.656/98, inseridos pela Lei 14.454/2022, *in verbis*:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)
>
> (...)
>
> § 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
>
> I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; **<u>ou</u>** (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

Diante do exposto, considerando ser o Rol de procedimentos da ANS exemplificativo, não se mostra razoável a recusa de custeio efetuada pela seguradora com base, exclusivamente, em tal dispositivo, mormente quando o procedimento cirúrgico pretendido se perfaz em tratamento mais adequado para tratar doença listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da OMS, qual seja: <u>CID 10: F 33.2, transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave.</u>

Destaque-se que cabe ao médico a decisão acerca do tratamento a qual deverá se submeter o seu paciente, tendo em vista que, nas palavras do Des. Cândido Saraiva, é sobre aquele profissional que recai a responsabilidade penal e civil do diagnóstico, tratamento e medicação indicada ao paciente (TJ-PE - APL: 4372841 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).

Sobre a matéria, colaciono outro julgado do STJ:

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA**.** APLICAÇÃO. SÚMULA Nº DO STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ROL TAXATIVO ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. **2. A Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde eleger qual o procedimento a que deve ou não se submeter o beneficiário,** indicação que cabe exclusivamente ao médico de confiança do paciente**. 3.** Quanto ao ponto, a decisão agravada não aplicou a Súmula nº 7 do STJ, razão pela qual o seu afastamento esbarra na falta de interesse recursal. **4.** Porque a alegação de que a OPERADORA não está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS não foi suscitada em recurso especial, se mostra inviável que seja discutido em agravo interno, por configurar indevida inovação recursal. **5.** Agravo interno não provido. **(AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)**

Assim sendo, cabe ao médico a decisão acerca do procedimento a que deverá se submeter o seu paciente, como sucede no caso vertente.

Diante do exposto, resta evidenciado o dever da demandada de custear o procedimento prescrito pelo médico que assiste o autor, Dra. Kátia Cristina Lima Petribu, CRM 9282 (ID 110022100).

Por fim, quanto à negativa ao tratamento sob o fundamento de que há exclusão contratual para a cobertura em razão das cláusulas 5.1 e 5.1.1, das Condições Gerais da Apólice, compete ser dito, à saída, que não correspondem as cláusulas constantes do contrato juntado aos autos no ID 115982000, que se encontra assinado pelo autor e pelo representante legal da Ré Unimed Natal.

As cláusulas de exclusão se encontram carreadas no item 10 do contrato (ID 115982000 – págs. 24/25), alíneas *r* e *s*, que excluem a cobertura para medicamento de uso domiciliar e os procedimentos não previstos no rol da ANS, todavia, as mesmas não se encontram redigidas em destaque. Ademais, não se pode perder de vista que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, por força da incidência da legislação consumerista, em especial o art. 47, do CDC.

As cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras, notadamente aquelas às quais os consumidores aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e na forma do que dispõe o artigo 51 do CDC.

Nesta toada, porquanto o contrato firmado entre as partes visa a prestação de serviços à saúde, havendo previsão de cobertura para a doença que o paciente apresenta, é justa a expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for recomendado.

Enfim, ***"ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.*** *Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com a imposição de multa. (AgRg no REsp 1450673/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014 (grifei).*

Assim, uma vez que prevê a cobertura para a enfermidade do autor – CID 10: F 33.2, transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave -, não pode o plano de saúde se recusar a autorizar procedimento imprescindível para o tratamento, qual seja, medicamento de uso hospitalar - Spravato, sob pena de a cobertura da moléstia não ser, efetivamente, realizada.

Para além disto, impende registrar que é entendimento firmado pela Corte da Cidadania de que "*considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label)*" (AgInt no AREsp 1682588/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Neste sentido, seguem recentes julgados do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **PLANO DE SAÚDE.** NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCECAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. **RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIO**R. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. (...) 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual **é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental**. 4. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da

> Terceira Turma desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, **DJe 10/03/2021**)
>
> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ**. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. **"Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário**. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp 1.680.415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe de 11/09/2020). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1875974/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe **17/12/2020**)

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que estava acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso indicado.

Suportando o autor não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu a demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento etc.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO**. 1. **A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença**. Precedentes. 2. Agravo interno não

provido.(STJ - AgInt no REsp: 1614203 RJ 2016/0186519-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.** PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. **DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1**. (...) 2**. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.** 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. **É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais**. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)**

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R $3.000,00 (três mil reais).**

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer, para condenar as rés, solidariamente, a custearem o tratamento medicamentoso SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), nos moldes solicitados pela psiquiatra assistente (Relatório Médico de ID 110022095 e 110022100), ratificando a tutela antecipada de ID 115477492.

(2) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais),** corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e custos do medicamento- obrigação de fazer, com valor aferível, nos moldes da Súmula 199 do TJPE, referente ao fornecimento do medicamento pelo período de seis meses), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Diretoria Cível à emissão das guias de custas devidas pela parte demandada, com sua posterior intimação para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 20%, sobre o valor devido atualizado, em conformidade com o art. 22 da Lei Estadual nº 17.116/2020.

Transcorrido o prazo sem o pagamento:

i) expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado, exclusivamente por meio eletrônico, sat@pge.pe.gov.br (mailto:sat@pge.pe.gov.br), se o débito for igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), caso em que o expediente também deverá ser acompanhado de cópia do título executivo judicial (sentença exequenda e, se houver, acordão), instrumentos procuratórios, atos constitutivos e outros documentos relevantes para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 2º, VII, da Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016, do TJPE (art. 3º, I, do Provimento 03/2022, de 10-03-2022, do Conselho da Magistratura;

(ii) expeça-se ofício ao Comitê Gestor de Arrecadação, por meio eletrônico, se o débito for inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais) (art. 3º, II, do Provimento 03/2022- CM).

Atente a Secretaria desta Vara ao disposto no art. 3º, § 1º e art. 4º, do Provimento 03/2022 do CM .

Comunique-se ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0019287-95.2022.8.17.9000 o resultado do presente julgamento.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 14 de fevereiro de 2023.

Virgínia Gondim Dantas
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
14/02/2023 16:53:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 125975988

23021416531325800000123087017

IMPRIMIR GERAR PDF